

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: MARIA HELENA DE CAMPOS SOARES

Sexo: Feminino

Data do Exame: 05-11-2024

Idade: 75 anos

Peso: 72 kg

Altura: 1,63 m

Médico Solicitante: DRA. MARIA CECILIA MENEZES
PIRES

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 05/11/2024 20:48 e finalizado às 06/11/2024 05:40.

A latência para início do sono foi de **80,0** min e a latência para o sono REM de **89,0** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 316,5 min, com eficiência do sono de **61,0** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **9,0** % de estágio N1, **42,5** % de estágio N2, **28,3** % de estágio N3 e **20,2** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 122,0 min. Ocorreram 74 despertares, sendo o índice de **8,6 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 101, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 1 apneias mistas, 100 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **19,1 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 22,5 e o IDR durante o sono NREM foi de 18,3. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 19,1 (nº/h), sendo 0,2 apneia/h e 19,0 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 93%, a média de 89% e a mínima de 76%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 6,6 (nº/h), sendo que em REM foi de 11,3 (nº/h) e em NREM foi de 9,5 (nº/h). Permaneceu 21,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Nome: MARIA HELENA DE CAMPOS SOARES

Data do Exame: 05-11-2024

pág. 1

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**19,1 n°/h**) moderadamente aumentado (VN= até 5 n°/h);
2. Presença de dessaturação da oxi-hemoglobina associado aos eventos respiratórios anormais;
3. Aumento da latência para o início do sono (**80,0 min**) (VN= até 30 min)
4. Latência para o início do sono REM normal (**89,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono diminuída (**61,0 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal **8,6 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Aumento do percentual do estágio N1 (**9,0 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (**42,5 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Aumento do percentual do estágio N3 ondas delta (**28,3 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**20,2 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco constante verificado via sensor de ronco durante a leitura do exame;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

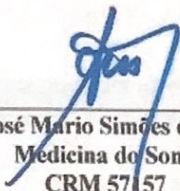
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157